基礎研レポート

2026 年度の社会保障予算を分析する

診療報酬は 30 年ぶりの高水準、介護・障害福祉も期中改定、高額療養費の見直しも

保険研究部 ヘルスケアリサーチセンター 上席研究員　三原 岳
(03)3512-1798　mihara@nli-research.co.jp

1――はじめに～2026 年度の社会保障予算を分析する～

政府の 2026 年度当初予算案に関する審議が 2025 年 2 月に召集された特別国会で本格的に始まった。2026 年度当初予算案は 2025 年 12 月に閣議決定された後、急転直下の解散総選挙で審議がストップしたが、内容に変更が加えられないまま、特別国会での審議が始まった。

一般会計の規模は対前年度当初比 6.2%増の 122 兆 3,092 億円となり、2 年連続の過去最大となった。このうち、歳出の約 3 分の 1 を占める社会保障関係予算は対前年度当初比 2.0%増の 39 兆 559 億円となった。今回は医療機関に対する診療報酬本体の見直しの年となり、物価上昇に伴って医療機関の経営危機が進む中、関係団体や与党から財政支援を求める声が強まった。結局、2025 年度補正予算で 1 兆円規模の国費による支援が講じられたほか、診療報酬の改定率がプラス 3.09%となり、30 年ぶりの高水準となった。

さらに、物価上昇に対応するため、介護報酬 2.03%、障害福祉サービス報酬は 1.84%の引き上げとなった。いずれも 3 年に 1 回の頻度で見直されており、次は 2027 年度改定が予定されていたが、2026 年度に前倒しで改定されることになった（いわゆる期中改定）。具体的には、2025 年度補正予算で介護、障害福祉は最大 1.9 万円の賃上げを図る経費が計上されたほか、2026 年 5 月に期限が切れた後も継続するための経費が 2026 年度当初予算案に盛り込まれた。

一方、社会保障費の伸び率を高齢化の範囲内に抑える「目安」対応も継続され、毎年恒例の薬価削減のほか、患者負担を抑える「高額療養費」の見直しも実施された。さらに、社会保険料の負担軽減を重視する日本維新の会が連立政権に加わったことで、医療費適正化策も論じられた。

本稿では、社会保障関係費を中心に、2026 年度当初予算案の概要や政策形成過程などを考察する。最初に、複雑な資金の出し入れが実施された地方財政も含めて、歳出と歳入の概況を把握した後、社会保障費の抑制策を検討する。その上で、医療提供体制改革や高齢者福祉、子ども家庭福祉などの領域に関して、新規事業を取り上げる。

なお、2025 年の臨時国会では総額 18 兆 3,043 億円の 2025 年度補正予算が成立しており、2026 年度当初予算案と一体的に編成されている施策も少なくない。このため、必要に応じて 2025 年度補正予算の内容にも触れる。

 | Copyright ©2026 NLI Research Institute All rights reserved

2――2026 年度政府予算案の全体像

1｜歳出と歳入の概況

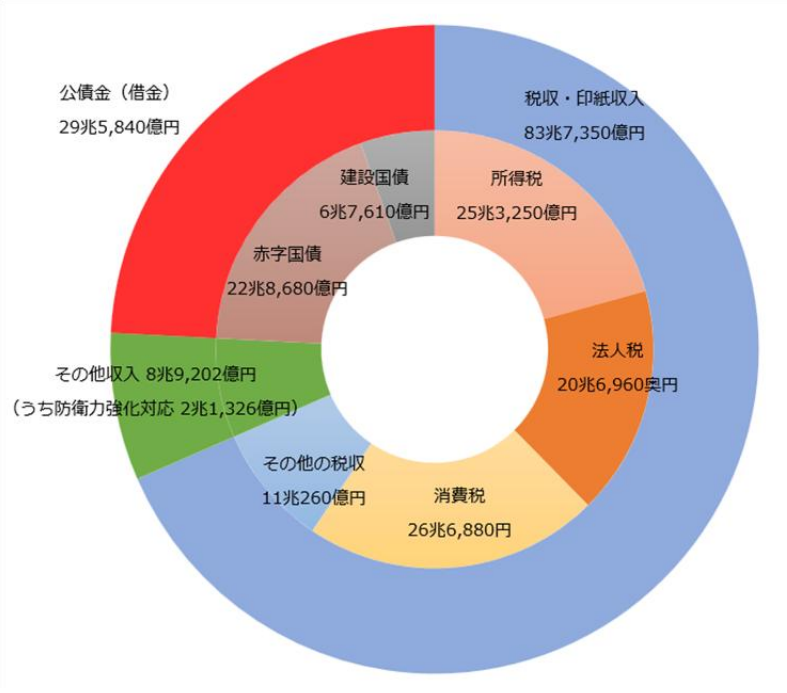
まず、2026 年度予算案の歳入と歳出の状況を概観する[1]。一般会計の規模は対前年度当初比で 6.2％増の 122 兆 3,092 億円となり、2 年連続で過去最高を更新した[2]。

このうち、歳入では図表 1 の通り、税収・印紙収入は対前年度当初比 7.6％増の 83 兆 7,350 億円となり、過去最高をマークした。歳入の規模に影響する税制改革では、揮発油税（ガソリン税）などの上乗せ税率（いわゆる暫定税率）が 2025 年 12 月に廃止されたほか、後述する通り、国民民主党の主張をほぼ丸呑みする形で、所得課税の非課税枠を引き上げることが決まったが、それを上回る企業収益の改善や物価上昇の影響で税収が上振れした[3]。

一方、公債金（国債、借金）の収入は 3.3％増の 29 兆 5,840 億円となった。

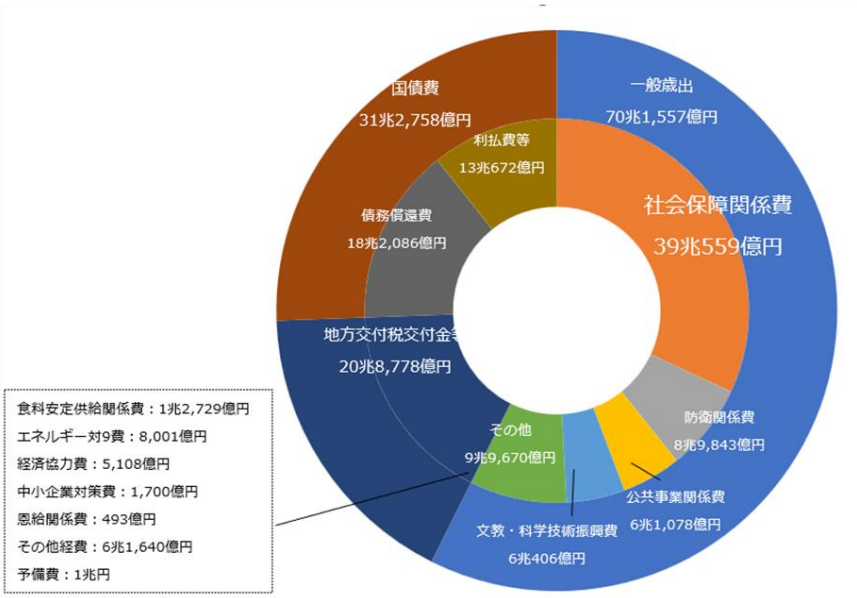
歳出は図表 2 の通りであり、政策的経費を示す一般歳出のうち、最大規模の社会保障関係費は対前年度当初比 2.0％増の 39 兆 559 億円となった。この規模を増やした要因とし

図表1：2026年度政府予算案の歳入内訳



出典：財務省資料を基に作成

図表2：2026年度政府予算案の歳出内訳



出典：財務省資料を基に作成

---

[1] なお、煩雑さを避けるため、発言などを除き、可能な限り引用や出典は省略するが、本稿執筆に際しては、首相官邸や内閣府、財務省、厚生労働省、総務省、こども家庭庁の各ウエブサイトを参照。メディアでも『朝日新聞』『共同通信』『産経新聞』『東京新聞』『日本経済新聞』『毎日新聞』『読売新聞』に加えて、『社会保険旬報』『週刊社会保障』『シルバー新報』『国保実務』『ミクス Online』『m3.com』『Gem Med』など専門媒体の記事も参考にした。

[2] 2025 年度予算の国会審議では、与党が過半数を抑えていなかったため、衆院と参院で修正を受けた。その結果、一般会計規模だけでなく、社会保障費や地方交付税交付金等の規模も 2024 年 12 月の閣議決定時点から大きく変動している。本稿では財務省の資料に沿って、対前年度当初の比較では修正後の数字を用いる。

[3] このほか、与党税制改正大綱では、岸田文雄政権期に決まっていた防衛費倍増に充てるため、所得税率を 1%上乗せすることが決まった。その際、当面の負担増を避けるため、東日本大震災の復興に充てている「復興特別所得税」のうち、1%分を振り向けるとしている。

Copyright ©2026 NLI Research Institute All rights reserved

て、物価上昇に対応するため、診療報酬、介護報酬、障害福祉サービス報酬を引き上げることが決まった一方、マイナスの側面として、医療費と社会保険料の抑制を重視する日本維新の会（以下、維新）の連立政権入りに伴い、社会保障費の伸びを自然増に抑える対応が続けられた。

2｜特異な動きを見せた地方財政

さらに、社会保障費の次にシェアが大きい地方交付税交付金等は対前年度当初比 10.7%増の 20 兆 8,788 億円となった。今回の予算編成では、地方財政に関して特異な動きが見られたので、本題の社会保障関係予算に入る前に、簡単に触れることにしたい。

まず、国から支出される地方交付税交付金等は「地方交付税」「地方特例交付金」に分かれる。このうち、前者は国の一般会計から「交付税及び譲与税配付金特別会計（以下、交付税特別会計）」を介して、自治体に配分される予算。いわゆる「入口ベースの交付税」と呼ばれており、所得税など国税の約 3 割が自動的に充当される仕組みになっている（いわゆる法定率分）。

これに過年度に発生した税収の増減に伴う精算分などを加味し、これらでも自治体全体の歳入を確保し切れない場合、国と自治体が赤字を折半で補填することになっている（いわゆる折半対象財源不足）。具体的には、国が赤字国債による「特例加算」で不足分の半分を穴埋めするほか、残りの半分については、自治体が臨時財政対策債（いわゆる赤字地方債）で賄うことになっており、いわゆる「折半対象財源ルール」と呼ばれる方法は 2001 年度から適用されている。最終的に交付税特別会計を通じて、自治体に配分される交付税は一般的に「出口ベース」の交付税と呼ばれる。

一方、地方特例交付金とは、減税など国の判断や事情で地方税が減った場合、国が自治体の減収を補填する仕組みを指す。いずれも最後は一般財源（自由に使える財源）として、自治体に配分される。近年の予算編成では、地方税と出口ベースの交付税、地方特例交付金の合計（いわゆる地方一般財源）を同額水準で維持する「地方一般財源総額実質同水準ルール」が運営されている。

こうした中、2026 年度当初予算案では、国の税収が過去最高規模になったことで、入口ベースの交付税のうち、法定率分が対前年度当初比 8.8%の 21 兆 106 億円に増えた。これに対し、過年度分の精算として 2,484 億円の減額が発生したほか、特例的に 7,000 億円を減じる対応が取られたが、法定率分の伸びが大きかったため、入口ベースの交付税は対前年度当初に比べて 1 兆 3,830 億円も増えた。これにガソリン税などの上乗せ税率の廃止[4]に伴って、地方特例交付金が対前年度当初に比べて 4 倍近く増え、8,156 億円となったことで、地方交付税交付金等の規模が膨らんだ。

ここで注目されるのは 7,000 億円の特例的な減額であり、交付税特別会計を使った複雑なやり繰りが実施された。これには交付税特別会計を巡る歴史が絡む。元々、2000 年度以前に不足分が発生した場合、国の財政投融資から資金を借り入れていた歴史があり、その際に元本と金利を国、自治体で返済する割合を決めていた。その後、2001 年度から折半対象財源ルールに移行したほか、過年度の債務のうち、2007 年度に国負担分を一般会計に継承したが、自治体負担とされた過去の借金は 2025 年度

[4] ガソリンに関する上乗せ税率の一部が地方揮発油譲与税として自治体の財源になっていたほか、軽油引取税にも上乗せ税率が適用されていた。このほか、燃費性能などに応じて、車を取得した時に課税されていた「環境性能割」が廃止されることで、地方税の自動車税、軽自動車税も減収になる。いずれも特例交付金で当分の間、自治体の税収の減少分が国の負担でカバーされる。

 Copyright ©2026 NLI Research Institute All rights reserved

現在で約 25 兆円も残されており、交付税特別会計から元本と利子が毎年のように返済されている。

今回の 2026 年度当初予算案では、入口ベースの交付税から 7,000 億円が減じられる一方、交付税特別会計の債務から同額を国の一般会計に継承することになった。少し分かりやすく言うと、自治体の現金収入から 7,000 億円を減らした半面、同額の借金返済の責任を自治体から国に振り替えた形だ。

こうした複雑なやり繰りが実施された背景として、国と自治体の双方の事情が考えられる。まず、国側の事情としては、国債発行額を 30 兆円以下に抑えたいという意向があったと推察される。補正予算を含めて歳出規模が膨らみ、長期金利が上昇を見せる中、市場の信任を得る上では、国債発行額を 30 兆円以下に抑制するため、地方財政を巡る「操作」で帳尻合わせが実施されたと推察される。さらに、ガソリン税などに関する上乗せ税率の廃止で地方税が約 7,000 億円減ったことに平仄を合わせる目的もあったとみられる。

次に、自治体の事情として、地方財政が好転していることで、やはり帳尻を合わせる必要があったと思われる。確かに個別の自治体では「財政危機」が話題になっている[5]が、国の税収増加が入口ベースの交付税に反映する上、地方税も全体としては伸びている。実際、折半対象財源不足は 5 年連続でゼロになった[6]だけでなく、2026 年度当初予算案と同時に決定された地方債計画の案では、2025 年度に続き、借り換えも含めた臨時財政対策債の発行がゼロになった。

しかし、既述した通り、最近の予算編成では「地方一般財源総額実質同水準ルール」が採用されており、これが一種の上限として機能している。このため、交付税総額を抑える必要があり、特例的な減額が必要とされたと予想される。

付言すると、地方財政計画では 8,376 億円の「臨時財政対策債償還基金（仮称）」を創設することも決まった。この仕組みでは、自治体が以前に発行した臨時財政対策債の償還が重視されており、やはり出口ベースの交付税を減らす要因として働く。

要するに、地方財政が全体として好転する中、国債発行額や地方交付税交付金等の規模を抑えるため、特例減額や臨時財政対策債償還基金の創設などの対応が取られたと言える。

3｜「年収の壁」などを巡る多党間連携

今回の予算編成では 2025 年度に続き、多党間連携が意識された点も見逃せない。当時の与党だった自民、公明両党は 2024 年 10 月の総選挙に続き、2025 年 6 月の参院選でも敗北したことで、予算や法律の審議に際して、野党の協力を仰ぐ必要に迫られた。

特に、2025 年度当初予算の審議では維新の協力を仰ぐことになり、「医療費を年 4 兆円削減」を掲げる維新に配慮する形で、3 党は社会保障の見直しに関する協議体を設置。2025 年 6 月には病床削減の加速に加えて、市販薬と同じ性能を持つ薬品（いわゆる OTC 類似薬）の保険適用の見直しを進めることで合意した[7]。

その後、2025 年 10 月に高市早苗政権が発足する際、公明党が連立から離脱する一方、維新が閣外

---

[5] 社会保障費や施設の維持更新費の増加に加えて、平成の大合併による財政優遇措置が切れており、一部の自治体では歳出カットに関して、住民の理解を求める事態に発展している。2025 年 11 月 7 日『朝日新聞』

[6] 当初予算ベースでは 2022～2026 年度に加えて、2007～2008 年度、2019～2020 年度も折半対象財源不足は解消している。

[7] 3 党合意の内容や経緯については、2026 年 2 月 27 日拙稿「臨時国会で成立した改正医療法で何が変わるのか（中）」を参照。

 Copyright ©2026 NLI Research Institute All rights reserved

協力で連立に加わる変動が起きた。さらに、自民党は維新離党組と統一会派を組むことで、衆院の過半数を回復した。それでも参院では過半数を得ておらず、自民党は2026年度当初予算案の編成に際して、維新との間で政策の調整を図りつつ、国民民主党の主張に配慮する対応を取った。

具体的には、「現役世代の手取り収入増」を掲げる国民民主党の意見を取り入れる形で、個人所得課税に関する「年収の壁」問題で譲歩を見せた。ここで言う個人所得課税に関する「年収の壁」とは、収入や所得から一定額を差し引ける控除の合計額を指しており、この「壁」を超えると課税対象になる[8]。国民民主党は基準の引き上げを主張し、2025 年度当初予算の編成に際して、当時の与党だった自民、公明両党と国民民主党は一旦、178 万円を目指して引き上げることで合意した。

ただ、財源対策などで折り合わず、2025 年度の時点では 160 万円に引き上げられた[9]が、国民民主党は納得せず、継続協議が続いていた。結局、2026年度当初予算案の編成に際して、自民党は国民民主党の主張を受け入れる形で、「178 万円」の引き上げを決定。自民と国民民主両党の合意に盛り込まれるとともに、自民党と維新がまとめた与党税制改正大綱に反映された。これに伴う国税の減収は約7,000億円に上ると見られている。

一方、自民、公明両党と維新は公立小学校の給食無償化でも合意した。この仕組みでは、2026年4月から児童1人当たり月5,200円を上限に給付する。財源は国と都道府県で折半し、地方分は地方交付税で必要額が措置される。国と地方を合わせた必要な財源は約3,300億円とされており、文部科学省の予算では1,649億円が新規事業として計上された。ただし、基準額を超える部分については、保護者からの徴収が可能とされている。

さらに、自民、公明、維新の3党は2025年2月、実質的な高校無償化でも一致しており、これに沿った拡充策が2026年度当初予算案で取られた。つまり、所得制限を撤廃するとともに、私立高校に対する助成額を45万7,200円に引き上げるなどの内容となっている。

4｜年度内成立は微妙？暫定予算は…

こうした多党間連携の枠組みは急転直下の衆院解散で大きく変容した。2026年1月に召集された通常国会の冒頭、高市首相は衆院を解散。2026年2月の総選挙では、自民党だけで獲得議席は3分の2を超え、維新を加えた衆院での占有率は約4分の3に及ぶ。一方、立憲民主党と公明党が結成した中道改革連合は大敗を喫し、高市首相が主導性を発揮しやすい状況になった。

それでもスケジュール的に年度内成立が微妙になったのは事実である。しかも参院は自民、維新を足しても過半数に満たないため、予算関連法案を含めた国会審議を円滑に進める上では、野党の協力が欠かせない。今後、暫定予算を組むのかどうかも含めて、国会審議や野党との関係が注目される。

3――社会保障予算の全体像

1｜骨太方針と概算要求基準の内容

社会保障予算に関しては近年、その伸び率を高齢化などによる増加分に相当する5,000億円程度に

[8] これ以外でも社会保険料の扶養家族に入るかどうかの線引きが就業調整に繋がると問題視されている。
[9] 2025年度予算編成の時点では103万円から123万円に引き上げられることになっていたが、衆院を通過する際、160万円まで引き上げられることが決まった。

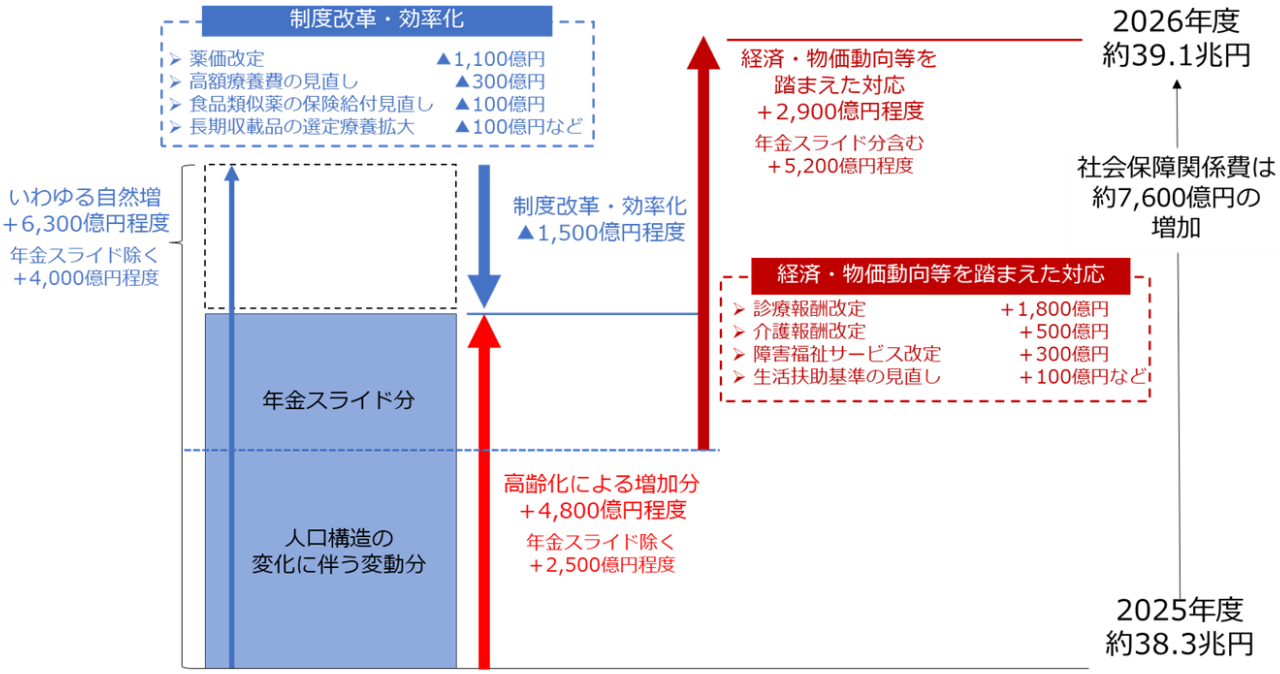
Copyright ©2026 NLI Research Institute All rights reserved

抑える方針（いわゆる「目安」対応）が継続されている。さらに、岸田文雄政権が重視した「次元の異なる少子化対策」では、必要経費の大宗を歳出抑制で賄う方針が決まっており、2023 年 12 月の「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）」（以下、改革工程）では、患者負担の見直しなど様々な歳出抑制策が列挙されている[10]。

一方、物価上昇や他の産業の賃上げが進む中、医療機関や介護・福祉事業所の経営悪化が深刻になったため、その対応策も重視された。例えば、経済財政政策の方向性を示す「経済財政運営と改革の基本方針」（骨太方針）の検討過程[11]では、日本医師会（以下、日医）など関係団体が報酬引き上げなどを強く要求した。その結果、2025 年 6 月に閣議決定された骨太方針では、「医療・介護・保育・福祉等の人材確保に向けて、保険料負担の抑制努力を継続しつつ、公定価格の引上げを始めとする処遇改善を進める」などの文言が盛り込まれた。

その半面、骨太方針では財政健全化の観点に立ち、「目安」対応の継続も決まり、「高齢化による増加分に相当する伸びにこうした経済・物価動向等を踏まえた対応に相当する増加分を加算する」という文言が入った。こうした議論を踏まえ、2025 年 8 月に閣議了解された概算要求基準でも同様の方針が決まった。つまり、社会保障費を減らす努力を継続しつつ、物価や経済情勢に配慮する形で社会保障費を引き上げる部分については別枠で対応することになったわけだ。

図表3：2026年度社会保障関係費の全体像



出典：財務省資料を基に作成
注：数字は概数。

[10] 改革工程の意味合いや内容などについては、2024 年 2 月 14 日拙稿「2024 年度の社会保障予算の内容と過程を問う（下）」を参照。
[11] 医療機関の経営危機の状況や背景、2025 年 6 月の骨太方針に至る過程については、2025 年 6 月 24 日拙稿「医療機関の経営危機、報酬改定と予算編成はどうなる？」を参照。

 Copyright ©2026 NLI Research Institute All rights reserved

2｜社会保障予算の全体像

その結果、社会保障予算の全体像は図表 3 の通り、プラスとマイナスが同居する複雑な姿となった。まず、年金の物価スライドを含む高齢化による自然増が 6,300 億円程度と見込まれる中、後述する通り、薬価の引き下げのほか、患者の窓口負担を抑える高額療養費の見直しなどによる抑制効果などを通じて、約 1,500 億円の国費（国の税金）が抑制された。

一方、経済・物価動向を踏まえた対応として、診療報酬引き上げなどを通じて 2,900 億円が別枠で計上されており、トータルでは約 7,600 億円の増になったと説明されている。

しかし、増額と抑制が入り混じる複雑な仕上がりについては、過去の予算編成でも取られていた[12]ため、骨太方針と概算要求基準を通じて別枠の取り扱いがオーソライズされたと言えるのかもしれない。

次に、こうした全体像に収まった社会保障予算のうち、診療報酬の大幅プラス改定を含めた「経済・物価対応等を踏まえた対応」の検討に移る。その際には、2025 年 12 月に成立した 2025 年度補正予算でも経済・物価対応のため、1 兆円以上のテコ入れ策が盛り込まれており、一部は一体的に運用されている。以下、2025 年度補正予算の内容を概観した後、2026 年度当初予算案の内容を検討する。

4――社会保障予算の「経済・物価動向等を踏まえた対応」

1｜2025 年度補正予算

2025 年 12 月に成立した 2025 年度補正予算では「医療・介護等支援パッケージ」（以下、支援パッケージ）と銘打ち、医療機関や介護事業所、障害福祉サービス事業所に対する支援予算が盛り込まれた[13]。具体的には、物価上昇などに苦しむ医療機関に対して全額国費の給付金が計上されるなど、医療だけでも計 1 兆円を超える予算が確保されており、思い切った対応が取られた。

このほか、介護・福祉職員についても、最大 1 万 9,000 円の賃上げに繋げる経費が全額国費で盛り込まれた。介護は 1,920 億円、障害福祉サービスは 439 億円。これらは後述する通り、2026 年 6 月から介護報酬、障害福祉サービス報酬に引き継がれることになった。

2｜診療報酬の引き上げ

さらに、医療機関の経営危機に対応するため、2026 年度当初予算案でも診療報酬本体の引き上げが図られた。医療機関に対する診療報酬本体は 2 年に 1 回見直されており、2026 年度は改定の年だった。このため、既に触れた通り、日医などは大幅な引き上げを要望。当初予算案の調整過程では、3%台を望む厚生労働省と、2%台に抑えたい財務省との間で綱引きが演じられたが、最終的に高市首相の裁断で 3.09%という高い水準で決着した。物価・賃上げ対応に要する 2026 年度当初予算案の国費（国の税金）は約 1,800 億円と目されている。

今回の引き上げ幅は図表 4 の通り、1994 年度以来、30 年ぶりの高水準であり、関係者からは「医療界の窮状をご理解いただけた」[14]、「（筆者注：2025 年度）補正予算と診療報酬改定で若干、延命でき

---

[12] 2025 年度予算については、2025 年 2 月 6 日拙稿「2025 年度の社会保障予算を分析する」、2024 年度予算の全体像については、2024 年 1 月 25 日拙稿「2024 年度の社会保障予算の内容と過程を問う（上）」を参照。

[13] 補正予算のパッケージに至る経緯や内容については、2025 年 12 月 23 日拙稿「補正予算に計上された『医療・介護等支援パッケージ』を読み解く」を参照。

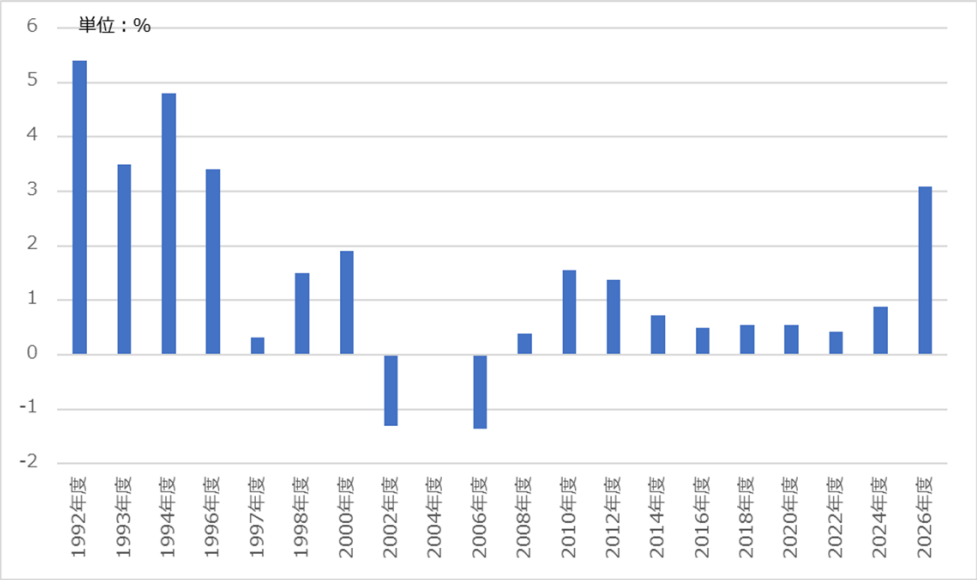
[14] 2025 年 12 月 24 日記者会見における日医の松本吉郎会長の発言。同日『m3.com』配信記事を参照。

Copyright ©2026 NLI Research Institute All rights reserved

る」[15]といった声が出ている。

さらに、引き上げの配分は予算決着の際、大枠が確定した。詳細な内訳は図表 5 の通り、2026 年度と 2027 年度の賃上げ対応で 1.70%、2026～2027 年度の物価対応で 0.76%、食費・光熱費分で 0.09%、2024 年度改定以降の経営悪化に対する緊急対応分で 0.44%という内訳である。

図表4：診療報酬本体の改定率の推移



出典：厚生労働省、日本医師会資料などを基に作成

その半面、価格が安い後発医薬品への置き換えや調剤報酬の見直し、住宅型有料老人ホームを舞台にした不正受給の疑いが指摘されている訪問看護の見直し[16]、一定の条件で繰り返し使える「リフィル処方箋」の拡大などを通じた給付削減として▲0.15%の抑制が見込まれている。

一方、市場実勢を考慮する形で薬価は▲0.87%、材料価格は▲0.01%となった。これは後述する通り、給付適正化の一つに位置付けられている。

今回の特色の一つとして、物価対応と賃上げ対応に関して、2026 年度、2027 年度の 2 段階での引き上げが採用された点を指摘できる。具体的には、賃上げ対応は 2026 年度で 1.23%、2027 年度で 2.18%、物価対応では 2026 年度に 0.55%、2027 年度に 0.97%と説明されている。

さらに、診療報酬増額の内訳を予算決着の時点で事前に決める方法は 2024 年度診療報酬改定から始まっており、今回も踏襲された[17]。特に、今回は何も色が付いていない「その他」の 0.25%に関しても、医科が 0.28%、歯科が 0.31%、調剤が 0.08%という形で事実上、財源を振り向ける分野が列挙された。このほか、改定率が決まる時点でマイナスを織り込む方法は 2022 年度診療報酬改定から始まっており、今回も継続された[18]。

最終的に、診療報酬の配分方法や加算の要件などは中央社会保険医療協議会（厚生労働相の諮問機関、以下、中医協）で協議され、2026 年 2 月に詳細が決まった。薬価は 2026 年 4 月、医療機関向け報酬は 2026 年 6 月から新たな体系に移行する。

---

[15] 2025 年 12 月 19 日記者会見における国立大学病院長会議の大鳥精司会長の発言。同日『m3.com』配信記事を参照。
[16] 有料老人ホームを舞台にした不適切とされる事案の構造や論点などについては、2025 年 8 月 27 日と 2025 年 9 月 26 日の拙稿「相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は？」（上下 2 回、リンク先は上）を参照。
[17] 2024 年度診療報酬改定のうち、賃上げ対応は 2024 年 6 月 12 日拙稿「2024 年度トリプル改定を読み解く（上）」を参照。
[18] 2022 年度診療報酬改定のうち、リフィルを含めた効率化の関係では、2022 年 5 月 16 日拙稿「2022 年度診療報酬改定を読み解く（上）」を参照。

 Copyright ©2026 NLI Research Institute All rights reserved

図表5：2026年度診療報酬、介護報酬、障害福祉サービス報酬改定の概要

診療報酬

改定率　＋3.09%
※ 令和８年度＋2.41%、令和９年度＋3.77%
（令和８年度予算額：国費2,348億円）

① 令和８・９年度の賃上げ対応★　＋1.70%
※令和８年度＋1.23%、令和９年度＋2.18%
✓ 医療従事者のベア3.2%（看護補助者・事務職員は5.7%）の賃上げを実現する措置。医療現場における一定の生産性向上等も想定
✓ 賃上げ余力の回復・確保を図りつつ幅広い医療関係職種での賃上げを確実にするための賃上げ対応拡充時の特例的な措置を実施

② 令和８・９年度の物価対応★　＋0.76%
※令和８年度＋0.55%、令和９年度＋0.97%
✓ 令和８年度以降の物価上昇に対応するため、医療機関の施設類型ごとの費用構造に応じて、きめ細やかな対応を実施。
✓ 物価対応本格導入時の特例的な対応として高度機能医療を担う病院（大学病院を含む）向けの措置を実施。

③ 食費・光熱水費分　＋0.09%

④ その他
・ **令和６年度改定以降の経営悪化への緊急対応分★　＋0.44%**
・ **その他　＋0.25%**
各科改定率　医科　＋0.28%、歯科　＋0.31%、調剤　＋0.08%

⑤ 効率化・適正化　▲0.15%
✓ 後発医薬品への置換えの進展を踏まえた対応、適切な在宅医療の推進のための対応、調剤報酬の適正化、長期処方・リフィル処方の取組強化など

※ ★の項目については、施設類型ごとのメリハリある配分をはっきりとわかる形で実現
※ 実際の物価等が見通しから大きく変動し、医療機関等の経営に支障が生じた場合には令和９年度予算編成において加減算を含め更なる必要な調整を行う

薬価等

改定率　▲0.87%
（令和８年度予算額：国費▲1,063億円）

① 薬価　▲0.86%　（国費▲1,052億円）
✓ 創薬イノベーションや医薬品の安定供給の確保を図りつつ、市場の実勢価格に応じた適正化を実施

② 材料価格　▲0.01%　（国費▲　11億円）

介護報酬改定

改定率　＋2．03%
（令和８年度予算額：国費518億円）

・ **介護分野の職員の処遇改善　＋1．95%**
✓ 介護従事者を対象に幅広く1.0万円賃上げを実現する措置
✓ 協働化等に取り組む事業者の介護職員を対象に0.7万円上乗せ措置（定期昇給込みで最大月1.9万円の賃上げが実現）

・ **食費の基準費用額の引上げ　＋0．09%**

障害福祉サービス等報酬改定

改定率　＋1．84%
（令和８年度予算額：国費313億円）
✓ 障害福祉従事者を対象に幅広く1.0万円賃上げを実現する措置
✓ 協働化等に取り組む事業者の福祉・介護職員を対象に0.3万円上乗せ措置（定期昇給込みで最大月1.9万円の賃上げが実現）

出典：財務省資料から抜粋

3｜介護・障害福祉報酬の引き上げの期中改定

さらに、介護・障害福祉サービス報酬に関しても引き上げが図られた。介護・障害福祉サービス報酬は3年に1回の頻度で見直されており、2026年度は改定の年ではなかったが、前倒しの改定（いわゆる「期中改定」）を通じて、物価高騰や厳しい経営状況が考慮された形だ。

介護・障害福祉サービス報酬に関しては、既述した2025年度補正予算の支援パッケージが絡む。まず、支援パッケージでは2026年5月までの時限措置として、最大月1万9,000円の賃上げを図るための経費が盛り込まれており、これらを2026年6月以降も介護報酬や障害福祉サービス報酬として継続するための費用が2026年度当初予算案に計上された。

2026年度当初予算案における改定率は図表5の通り、介護でプラス2.03%であり、内訳は職員の給与改善で1.95%、食費の基準額引き上げで0.09%。障害福祉サービス報酬改定は1.84%のアップとなる。これに必要な国費（国の税金）は介護で518億円、障害福祉サービス報酬で313億円。

一方、2026年度当初予算案では「制度改革・効率化」として給付抑制策が取られた。さらに、2026年度当初予算案に反映されていないが、3年に一度の介護保険制度改革のほか、医療費適正化を重視する維新との政策協議でも、成分などが市販薬（OTC薬）に似ている「OTC類似薬」の保険給付見直しなどが焦点になった。

以下、給付抑制や負担軽減に関わる制度改正として、(1) 薬価削減、(2) 高額療養費の見直し、(3) 食品類似薬の保険給付見直し、(4) 長期収載品に関する患者負担引き上げ、(5) OTC類似薬の保険給付見直し、(6) 3年に一度の介護保険見直し論議、(7) 中小企業の従業員や家族が加入する協会けん

Copyright ©2026 NLI Research Institute All rights reserved

ぽの保険料引き下げ――の概要を取り上げる。

5――社会保障予算の「制度改革・効率化」

1｜薬価の削減

薬価は 2021 年度以降、毎年度の改定となっており、2026 年度予算案では市場実勢に合わせる形で、0.87%のマイナスとなった。その削減効果は国費ベースで約 1,063 億円。

図表6：高額療養費に関する見直し案

現在の年収区分	現在の月額上限	現在の外来特例の月額上限
約1,160万円～	25万2,600円＋1%<14万100円>	――
約770万円～約1,160万円	16万7,400円＋1%<9万3,000円>	――
約370万円～約770万円	8万100円＋1%<4万4,400円>	――
～約370万円	5万7,600円<4万4,400円>	1万8,000円（年14万4,000円）
70歳未満住民税非課税	3万5,400円<2万4,600円>	――
70歳以上住民税非課税	2万4,600円	8,000円
70歳以上一定所得以下	1万5,000円	8,000円

2026年8月以降の年収区分	2026年8月以降の月額上限	2026年8月以降の年間上限	2026年8月以降の外来特例の月額上限
約1,160万円～	27万300円＋1%<14万100円>	168万円	――
約770万円～約1,160万円	17万9,100円＋1%<9万3,000円>	110万円	――
約370万円～約770万円	8万5,800円＋1%<4万4,400円>	53万円	――
～約370万円	6万1,500円<4万4,400円>	53万円（※）	2万2,000円（年21万6,000円）
70歳未満住民税非課税	3万6,900円<2万4,600円>	29万円	――
70歳以上住民税非課税	2万5,700円<2万4,600円>	29万円	1万1,000円（年9万6,000円）
70歳以上一定所得以下	1万5,700円	18万円	8,000円

2027年8月以降の年収区分	2027年8月以降の月額上限	2027年8月以降の年間上限	2027年8月以降の外来特例の月額上限
約1,650万円～	34万2,000円＋1%<14万100円>	168万円	――
約1,410万円～約1,650万円	30万3,000円＋1%<14万100円>	168万円	――
約1,160万円～約1,410万円	27万300円＋1%<14万100円>	168万円	――
約1,040万円～約1,160万円	20万9,400円＋1%<9万3,000円>	110万円	――
約950万円～約1,040万円	19万9,400円＋1%<9万3,000円>	110万円	――
約770万円～約950万円	17万9,100円＋1%<9万3,000円>	110万円	――
約650万円～約770万円	11万400円＋1%<4万4,400円>	53万円	――
約510万円～約650万円	9万8,100円＋1%<4万4,400円>	53万円	――
約370万円～約510万円	8万5,800円＋1%<4万4,400円>	53万円	――
約260万円～約370万円	6万9,600円＋1%<4万4,400円>	53万円	2万8,000円（年21万6,000円）
約200万円～約260万円	6万5,400円＋1%<4万4,400円>	53万円	2万8,000円（年21万6,000円）
～約200万円	6万1,500円＋1%<3万4,500円>	41万円	2万2,000円（年21万6,000円）
70歳未満住民税非課税	3万6,900円<2万4,600円>	29万円	――
70歳以上住民税非課税	2万5,700円<2万4,600円>	29万円	1万3,000円（年9万6,000円）
70歳以上一定所得以下	1万5,700円	18万円	8,000円

出典：厚生労働省資料を基に作成
注１：<>の金額は多数回該当の上限。
注２：「※」の～200万円区分は年上限41万円を適用、2027年8月から償還払い。

2｜高額療養費の見直し

高額療養費の見直しは 2025 年度からの積み残し案件であり、簡単に経緯を説明する[19]。2025 年度当初予算の編成に際して、厚生労働省は 2025 年 8 月以降、3 段階で高額療養費の上限の引き上げを目指したが、引き上げ幅が急だった上、患者団体の意見を聞かなかったプロセスなどに批判が集まった。特に、長期療養の患者を対象とした「多数回該当」も大幅に引き上げる案だったため、患者団体が強く反発した。結局、見直しに伴う国費（国の税金）の削減額を盛り込んでいた 2025 年度当初予算が 3 度も修正を受ける異例の事態に発展し、政府は 2025 年 3 月、事実上の白紙撤回を決めた。

その後、厚生労働省は 2025 年 5 月、社会保障審議会（厚生労働相の諮問機関）医療保険部会に「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」を設置し、患者団体の意見を聞きつつ、見直し論議を再開させた。

結局、片山さつき財務相と上野賢一郎厚生労働相の折衝を経て、2025 年 12 月にまとまった見直し

[19] 高額療養費見直しの経緯については、2025 年 4 月 10 日拙稿「異例ずくめの高額療養費の見直し論議を検証する」を参照。

 Copyright ©2026 NLI Research Institute All rights reserved

案では昨年の案よりも全体的に引き上げ幅を抑えた。詳細は図表 6 の通り、昨年の案と同様、高所得者の上限を高く設定する「応能負担」を強化しつつ、▽2026 年 8 月から 2 段階で引き上げ、▽住民税非課税世帯などを除き、現在の 4 区分を 12 区分に変更、▽年間単位で合算できる仕組みを創設、▽所得の低い階層の上げ幅を抑制、▽多数回該当は据え置き――といった内容が盛り込まれた。

一方、70 歳以上を対象とする外来特例については昨年度の案と同じ程度に引き上げる反面、所得が一定以下では 8,000 円で据え置かれることになった。

その結果、2026 年度当初予算案での給付抑制額は国費ベースで 300 億円程度、最終的に計▲2,450 億円になると見られている。前回の案が計▲5,300 億円程度だったことを考えると、約半分になった形だ。

なお、高額療養費の限度額は政令事項であり、引き上げ自体に法改正は不要である。しかし、削減額が 2026 年度当初予算案に反映されており、予算審議の対象になる。その際には、高市首相が自民党総裁選における共同通信のアンケートに対し、「負担上限額を引き上げるべきでない」と答えた経緯との整合性が論点となりそうだ[20]。

3｜食品類似薬の保険給付見直し

食品類似薬の保険給付見直しは 2025 年 12 月、自民党と維新の政調会長合意で盛り込まれた案件である。つまり、合意文では「栄養保持を目的とした医薬品のうち、代替可能な食品が存在する医薬品について、経口による食事から栄養補給可能な患者に対する使用は保険給付外とする」「手術後の患者、経管により栄養補給を行っている患者などについては、引き続き保険給付の対象とする」という文言が入った。

結局、2026 年 2 月に決まった診療報酬改定の細目では、口を経由して食事摂取できる患者に対する一部薬品については、保険給付の対象から外れた。

4｜長期収載品に関する患者負担の引き上げ

長期収載品に関する患者負担の引き上げは 2024 年 10 月から始まった仕組みであり、保険給付の圧縮とともに、医薬品メーカーの技術革新を促すことが企図されている。具体的には、後発医薬品（いわゆるジェネリック）が普及している先発医薬品（いわゆる長期収載品）のうち、上市後 5 年経過または後発医薬品の置き換えが 50%以上となった医薬品を使った場合、保険給付の範囲が縮小され、後発医薬品の最高価格帯との差の 4 分の 3 に限定される代わりに、患者から「特別の料金」を追加的に徴収することになった。つまり、価格の差額の 4 分の 1 を患者負担にした。

今回の制度改正では、2026 年 10 月以降、患者負担の割合を 25%から 50%に引き上げることが目指されており、給付抑制額は国費（国の税金）ベースで約 100 億円と見られている。

5｜OTC 類似薬の保険給付見直しなど

さらに、2026 年当初予算案の編成では、OTC 類似薬の見直しも論点になった。この関係では、2025

[20] 2025 年 11 月 4 日『朝日新聞デジタル』『共同通信』配信記事を参照。

 Copyright ©2026 NLI Research Institute All rights reserved

年度当初予算が衆院を通過した際、当時の与党だった自民、公明両党は維新の協力を受けることを決定。3 党は 2025 年 2 月の合意で、OTC 類似薬の見直しを進めることで一致した。

さらに、3 党は 2025 年 3 月に発足した協議体で議論を進め、2025 年 6 月の合意文では OTC 類似薬に関して、「医療の質やアクセスの確保、患者の利便性を考慮しつつ、医療保険制度の持続可能性確保を目指すことを基本とし、2025 年末までの予算編成過程で十分な検討を行い、早期に実現が可能なものについては、2026 年度から実行する」という一文が盛り込まれた。その後、公明党が連立を離脱する変動が起きたが、入れ替わるように維新が政権に入ったため、OTC 類似薬の見直し論議は絶えず進められた。

しかし、医療保険部会では患者団体から「公的な保険給付から外れてしまいますと、(略) およそ数十倍という相当程度の過重な負担増となる可能性があります」という意見が示された[21]ことで保険給付の対象から外すのではなく、追加負担を課すことが決まった。

結局、2025 年 12 月に交わされた自民、維新の政調会長合意でも、解熱鎮痛剤のロキソニンなど 77 成分 1,100 品目を対象に、薬剤費の 4 分の 1 に特別の料金を上乗せすることで決着した。2027 年 3 月の実施が想定されている。

6｜3 年に一度の介護保険見直し論議

3 年に一度の見直し論議が進められた介護保険制度でも、給付抑制策が焦点になった[22]。この関係では、(1) 一定以上の所得水準の利用者に課している 2 割負担の対象者拡大、(2) 全額が保険給付で賄われているケアマネジメントの有料化、(3) 要介護 1～2 の給付見直し――という 3 つの案件が前回の 2024 年度改正から積み残しとなっていたため、社会保障審議会介護保険部会で論点になった。

しかし、結論を先取りすると、「小粒」な案件となった。1 番目の 2 割負担対象者拡大については、介護保険制度が 2000 年度にスタートした際、所得とは無関係に 1 割負担とされていたが、介護保険の給付費が増加しているため、保険料負担を抑える観点に立ち 2015 年 8 月から 2 割負担、2018 年 8 月から 3 割負担が導入された。

ここで 2 割負担の線引きを定める「280 万円以上」という基準を引き下げれば、国や自治体の公費（税金）や、40 歳以上の国民に課されている介護保険料の負担を軽減できるため、その是非が 2021 年度改正から議論の俎上に上っている。

しかし、介護保険部会では賛否の意見が割れ、前回改正では「2022 年 12 月→2023 年夏→2023 年 12 月」と結論を持ち越した挙句、最終的に 2027 年度制度改正に先送りされた。

今回も「所得基準を引き上げた上で、月額 7,000 円の負担上限を設定」「幅広い階層で 2 割負担に引き上げた上で、一定程度の水準よりも預貯金が低い人は 1 割負担に戻す」という案が示されたが、結論が先送りされた。

なお、結論を出す時期について、2025 年 12 月の介護保険部会意見書では、「(筆者注：2027 年度か

[21] 2025 年 11 月 20 日医療保険部会議事録における天野慎介・全国がん患者団体連合会理事長の発言。
[22] 介護保険改正の論点については、2025 年 7 月 29 日拙稿「介護保険改正の論点を考える」を参照。このうち、3 つの論点に関しては、2025 年 12 月 12 日拙稿「三度目の正直？ケアマネジメント有料化論議の行方は」、を参照。2024 年 3 月 1 日拙稿「介護保険の２割負担拡大、相次ぐ先送りの経緯と背景は？」、2023 年 12 月 27 日拙稿「介護軽度者向け総合事業のテコ入れ策はどこまで有効か？」をそれぞれ参照。

 Copyright ©2026 NLI Research Institute All rights reserved

ら始まる）第10期介護保険事業計画期間の開始まで」と書かれており、市町村が3年サイクルで作成する次の介護保険事業計画が始まる2027年度までに結論を出すとされた。この方向性は向こう3年間の歳出改革などを盛り込んだ2025年12月の「経済・財政新生計画改革実行プログラム」にも踏襲されており、結論を出す時期としては、骨太方針が決まる2026年6月頃になると思われる。

2つ目のケアマネジメント有料化も、以前の制度改正から結論が持ち越された案件である。ケアマネジメントは制度創設時から利用者負担を徴収しておらず、財務省は他の介護サービスとの均衡を図る観点に立ち、2021年度制度改正から有料化を唱えている。

今回の制度改正に際しては、厚生労働省は選択肢として、▽利用者の所得状況を金額に反映させる案、▽住宅型有料老人ホームの入居者を対象にする案、▽給付管理業務の実費相当分を求める案――の3つの案を提唱した。

このうち、2つ目の案については、有料老人ホームを舞台にした訪問看護の不適切とされる事例の適正化の側面を持っており、この選択肢だけが実行されることになった。詳細は介護報酬改定を検討する社会保障審議会介護給付費分科会で検討される見通しだ。

3点目のうち、総合事業は2015年度の制度改正を通じて、要支援1～2の訪問介護と通所介護（デイサービス）が介護保険給付から切り離されるとともに、既存の介護予防事業と統合される形で発足した。さらに、住民同士の運動教室などにも財政支援できるようにするなど、市町村の判断で報酬や基準を独自に決められるようにした。

ここで期待されていたのは軽度者の身体的自立の促進と給付費の抑制であり、財務省は総合事業の対象者を要介護1～2に拡大するように主張したが、現在でも総合事業が市町村に浸透していないなどの理由で、2027年度改正に結論が先送りされていた。

今回も同様の理由で結論が先送りされており、2025年12月の経済・財政新生計画改革実行プログラムでは2027年度までの予定として、「引き続き検討を行い、検討の結果に基づき、必要な措置を講ずる」と書かれた。

7｜協会けんぽの保険料引き下げ

このほか、給付適正化策の文脈ではないが、現役世代の手取りを増やす流れの「余波」を受ける形で、中小企業の従業員や家族が加入する協会けんぽの保険料引き下げが決まった。近年の賃上げや適用拡大を踏まえ、協会けんぽの財政状況は好転しており、2024年度現在の積立金は過去最高の5兆8,862億円にまで積み上がっている。そこで、2026年度から全国平均の保険料を平均10%から平均9.9%に引き下げることが決まった[23]。協会けんぽの保険料引き下げは前身の政府管掌健康保険時代の1992年度以来、34年ぶり。

さらに、2025年12月の閣僚折衝では、協会けんぽに対する国庫補助金を特例的に差し引く「特例減額」の枠組みが強化されることも決まった。これには協会けんぽの制度改正の経緯をたどる必要がある。

協会けんぽの医療給付費に対する国庫補助金は民主党政権期の2010年度に13.0%から16.4%に引

[23] ただ、協会けんぽの保険料は2006年医療制度改革を経て、都道府県単位の支部ごとに保険料が設定されることになっており、料率の変化は支部ごとに異なる。

Copyright ©2026 NLI Research Institute All rights reserved

き上げられた一方、2012 年度から平均保険料率が 10.0%で維持されている。2024 年度決算ベースで国庫補助金は約 1 兆 1,700 億円に上る。

一方、2015 年に改正された健康保険法では、国庫補助率が「当分の間」、16.4%と規定された半面、準備金残高が積み上がる場合、剰余金（単年度収支差の黒字分）の国庫補助相当額を減額する仕組みが設けられた。2026 年度当初予算案に関する大臣折衝では、剰余金がプラスとなった翌年度の 2011 年度から 2014 年度までの間、特例減額が実施されていたと仮定した場合、約 1,500 億円の国費が浮いていた計算になり、2028 年度までの 3 年間で毎年 500 億円ずつ控除額に上乗せすることが決まった。

以上、2026 年度当初予算案のうち、「経済・物価動向等を踏まえ対応」「制度改革・効率化」を概観した。このほかにも 2025 年度補正予算も含めて、幾つか目立った施策が盛り込まれている。以下、2025 年度補正予算の内容も踏まえつつ、(1) 医療、(2) 高齢者福祉、(3) 子ども家庭福祉、(4) その他福祉、雇用――に大別して施策を考察する。

6――社会保障予算の主な新規事項(1)医療

1｜偏在是正など医療提供体制改革

まず、医療提供体制改革では、2025 年臨時国会で成立した改正医療法に関わる予算が盛り込まれた。改正医療法では、病床再編などを目指す「地域医療構想」を 2040 年まで継続するほか、医師偏在是正対策を強化することが企図されている[24]。

このうち、前者ではベッド数を減らす医療機関を支援する「病床数適正化支援事業」として、2025 年度補正予算で 3,490 億円が盛り込まれた。さらに医師偏在是正の関係[25]では、中堅医師が地方で勤務してもらう選択肢を広げる一環として、都道府県域を超えた広域的なマッチングを強化するための予算として、2025 年度補正と 2026 年度当初予算案で、それぞれ 2 億円が計上された。このほか、総合的な診療能力を学んでもらうリカレント教育の実施経費として、2025 年度補正予算で 1 億 1,000 万円、2026 年度当初予算案で 1 億 700 万円が盛り込まれた。

これらの医療提供体制改革に関しては、税制面でのテコ入れ策も決まった。具体的には、医療機関が病床再編で取得した不動産に関して、登録免許税と不動産取得税を通常よりも軽減する特例措置の期限が 2026 年 3 月末で期限切れとなるため、2 年間延長することが決まった。

さらに、医師偏在対策に関しても、重点的に予算や人員を投入する「重点医師偏在対策支援区域」[26]

---

[24] 地域医療構想とは 2017 年 3 月までに都道府県が作成した文書を指す。具体的には、人口的にボリュームが大きい「団塊世代」が 75 歳以上になる 2025 年をターゲットに、救急患者を受け入れる「高度急性期」「急性期」、リハビリテーションなどを提供する「回復期」、長期療養の場である「慢性期」に区分しつつ、都道府県が医療需要を病床数で推計。さらに、自らが担っている病床機能を報告させる「病床機能報告」で明らかになった現状と対比させることで、需給ギャップを明らかにした。その結果、全国的な数字では、高度急性期、急性期、慢性期が余剰となる一方、回復期は不足するという結果が出ており、高度急性期や急性期病床の削減と回復期機能の充実、慢性期の削減と在宅医療の充実が必要と理解されており、地域での協議を通じて、医療提供体制を再構築することが想定されている。だが、目標年次が到来したため、厚生労働省は 2040 年を見据えた「新たな地域医療構想」を本格化させており、2027 年度から地域での協議が始まる見通し。そのための改正医療法が 2025 年臨時国会で成立した。新たな地域医療構想を巡る論点については、2026 年 1 月 30 日拙稿「臨時国会で成立した改正医療法で何が変わるのか（上）」を参照。

[25] 医師偏在是正に関する経緯などについては、2024 年 11 月 11 日拙稿「医師の偏在是正はどこまで可能か」を参照。

[26] 2025 年 12 月の改正医療法で創設された仕組み。厚生労働省は対象地域として、「今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師が確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域」を想定しており、都道府県が決定する。

 Copyright ©2026 NLI Research Institute All rights reserved

で診療所を承継・新設する場合、登録免許税と不動産取得税を軽減する措置が創設される。

2｜地方財政での支援

さらに、総務省が所管する地方交付税でも公立病院に対する支援が図られた。まず、物価高騰を踏まえ、一般会計から病院事業に対する繰出金の費用を考慮するため、1 床当たりの単価が 8～9%程度引き上げられた。さらに、公立病院の新設・建替に関わる建築単価も 1 平方メートル当たり 59 万円から 85 万円にアップされることになった。

ただ、これらは各自治体に配分される普通交付税の計算ルールの変更であり、実際に自治体に配分される交付税の増額に繋がるとは限らない。

さらに、不採算地域で中核的な役割を果たしている公立・公的病院に関しても、特別な財政需要を考慮する特別交付税の基準額が 30%引き上げられた。

3｜大学病院向け予算の拡充

文部科学省の予算でも、大学病院に関わる事業が 2025 年度補正予算と 2026 年度当初予算案に盛り込まれた。このうち、2025 年度補正予算では経営環境の改善に繋がる人件費や設備投資を支援する「大学病院機能強化推進事業」として、349 億円が振り向けられた。2026 年度当初予算案でも、総合的な診療能力を有する医師など、地域医療を担う人材を養成する大学に対する予算として、36 億円が計上された。

さらに、地域医療構想の推進に関して、高等教育機関における人材育成の在り方などについて、高等教育機関のトップと地方公共団体の首長などで構成する「地域構想推進プラットフォーム」を構築するための事業として、7 億円が確保された。

7――社会保障予算の主な新規事項(2)高齢者福祉

1｜訪問介護などのサービス継続支援

高齢者福祉の関係では、物価上昇で経営難に直面する訪問介護を中心に、サービス継続を支援する予算が幾つか盛り込まれた。この関係では 2025 年度補正予算でも同様の事業が盛り込まれており、2026 年度当初予算案でも継続された形だ。

具体的には、2025 年度補正予算では協働化などを目指す「訪問介護等サービス提供体制確保支援事業」が計上されており、2026 年度当初予算案では、都道府県単位に設置されている「地域医療介護総合確保基金」を通じて、自治体の判断で同様の使途に使えるようにしている。

さらに、2025 年度補正予算では、サービスの調整などを担うケアマネジャー（介護支援専門員）の支援策としても、▽資格を有しているのにケアマネジャーとして従事していない「潜在ケアマネジャー」の発掘、▽利用者や家族の郵便物の投函など報酬が付かない業務について、ケアマネジャーが事実上、無償で従事している「シャドゥワーク」[27]の相談窓口の設置――などに取り組むための「地域

[27] 厚生労働省は 2024 年 4 月、「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」を設置し、2024 年 12 月までにケアマネジャーの研修や業務範囲などを検討した。このうち、業務範囲については、郵便・宅配便の発送や部屋の片付けなど法定業務以外の業務（いわゆるシャドウワーク）の整理が論点となり、市町村が地域課題として対応を協議する方向性が示された。

Copyright ©2026 NLI Research Institute All rights reserved

のケアマネジメント提供体制確保等に向けた総合対策」が盛り込まれており、こちらも2026年度当初予算案では地域医療介護総合確保基金で支援できるようにした。

2｜生産性向上など

デジタル技術の活用など介護現場の生産性向上[28]に向けて、研究開発から市場展開までのスタートアップを支援するCARISO（CARe Innovation Support Office）が2025年6月からスタートしており、2025年度補正予算と2026年度当初予算案でも「介護テクノロジー開発等加速事業」として、調査・研究に要する予算が確保された。介護現場の生産性向上や職場環境改善では、▽デジタル技術を駆使できる人材を養成するための教材、ツールづくり、▽小規模事業所の協働化、大規模化に向けた支援――などに関わる経費も計上された。

このほか、生産年齢人口の減少が本格化する2040年を意識し、「離島・中山間地域等サービス確保対策事業」が拡充された。これは人員基準などを特例的に緩和している「離島等相当サービス」の活用を促しつつ、事業者の協働などを促すことが企図されている。

8――社会保障予算の主な新規事項(3)子ども家庭福祉

1｜次元の異なる少子化対策の関係

子ども家庭福祉の分野では、岸田文雄政権で決まった「次元の異なる少子化対策」で児童手当の大幅拡充などの施策が進められており、2026年度も踏襲・強化された。施策としては、理由を問わずに使える「こども誰でも通園制度」の全国展開のほか、物価上昇に対応する保育士の処遇改善、育児期間中のパートやフリーランスの人を対象にした年金保険料の免除などが盛り込まれている。

2｜子どもの自殺対策

子ども家庭福祉分野では、児童生徒や若者に関する自殺対策が省庁横断的に強化された。この関係では、こどもの年間自殺者数が2024年に過去最高を突破したため、2025年通常国会では自殺対策基本法が改正され、子どもの自殺の防止などに関する国と学校の責務が追加された。

こうした流れを踏まえ、2026年当初予算案のうち、こども家庭庁の予算では、医療機関や学校、支援団体などで構成する協議体を設置するモデル事業の経費が盛り込まれた。さらに、デジタル技術を使った早期発見や要因分析、広報活動などにも取り組むとしている。

厚生労働省の事業でも、自殺対策に取り組む自治体を支援する「地域自殺対策強化交付金」が拡充され、精神科医、心理師、精神保健福祉士、弁護士などで構成する「こども・若者の自殺危機対応チーム」を拡大する方向となった。文部科学省としても、学校と医療機関など関係機関の連携を促すガイドラインを2026年度に作成し、早期対応の必要性を教育現場に周知するとしている。

この方向性は2025年12月の介護保険部会意見書に反映された。詳細については、2026年2月18日拙稿「昨年末に示された介護と福祉の部会意見書を読み解く（上）」を参照。

[28] 生産性向上に関する2024年度制度改正と報酬改定の議論については、2024年5月23日拙稿「介護の『生産性向上』を巡る論点と今後の展望」を参照。

Copyright ©2026 NLI Research Institute All rights reserved

3｜プレコンセプションケアの強化

こども家庭庁の予算では、妊娠前から健康づくりなどに取り組む「プレコンセプションケア」の充実に関する予算も盛り込まれた。この関係では、こども家庭庁の検討会が 2025 年 5 月、知識普及や相談支援の強化などを盛り込んだ「プレコンセプションケア推進 5 か年計画」を作成しており、政府としても骨太方針に 2025 年度版まで 3 年連続で言及するなど重視している。

2026 年度当初予算案では、こども家庭庁の予算として、オンライン相談の実施など地域の産婦人科クリニックなどと連携しつつ、思春期のこどもが相談しやすい体制を整備するほか、不妊治療などのアクセスを改善するため、自宅または里帰り出産の土地からクリニックなどで受診する際、60 分以上掛かる場合には交通費の一部を助成するとしている。予算額は 12 億円。

4｜その他の施策

さらに、財政力が低い市町村の関連施策を支援するため、国の補助事業として、「地域こども政策推進事業」が 2026 年度からスタートする。2026 年度当初予算案の計上額は 10 億円。

このほか、▽2026 年 12 月に施行されるこども性暴力防止法[29]に関する相談窓口の設置、▽低所得のひとり親や子育て世帯を対象に、自治体が公民館を活用しつつ、夏休みなどの間で食事や居場所を提供する事業の実施――などに要する費用も盛り込まれた。2025 年度補正予算では、子どもを持つ全世帯に「物価高対応子育て応援手当」として、子ども 1 人当たり 2 万円が児童手当に上乗せされた。

9――社会保障予算の主な新規事項(4)その他福祉、雇用

1｜包括的な支援体制整備の関係施策

その他の分野では、分野や属性を問わずに支援する「包括的な支援体制整備」に関する施策の拡充が盛り込まれた。小規模市町村を対象に分野横断的な相談対応を「機能集約アプローチ」と銘打った上で、これに関わるモデル事業の予算が計上されたほか、こうした市町村を支援する国や都道府県の人材育成、専門家派遣などに関わる事業も盛り込まれた。

さらに、生活保護になる前の人や世帯を対象に、分野横断的に相談を受け付けたり、就労や社会参加を促したりするため、2015 年度に創設された「生活困窮者自立支援事業」の拡充が図られ、▽住まいに関する相談機能の充実、▽就労準備支援や家計改善などのプラン件数が増えた対象自治体の支援拡充――などが盛り込まれた。

しかし、2021 年度から本格的に始まった「重層的支援体制整備事業」（以下、重層事業）については、自治体向け交付金の配分額が削減された。厚生労働省の想定を上回るスピードで、重層事業に取り組む市町村が増えたため、各市町村に配分する交付金が最大 7 割カットされた。その分、重層事業ではなく、生活困窮者自立支援事業を前面に押し出そうとする意図も見え隠れしている[30]。

このほか、2025 年 12 月の社会保障審議会福祉部会の意見書では、身寄りのない高齢者の日常生活支援などに関する新たな事業を創設する必要性が提唱されており、2025 年度補正予算に必要経費が盛

---

[29] 正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」。
[30] 重層事業の自治体向け予算カットの経緯については、2026 年 2 月 5 日拙稿「厚生労働省『肝煎り』の福祉事業が失速？（上）」を参照。

Copyright ©2026 NLI Research Institute All rights reserved

り込まれた。予算額は7億1,000万円。

2024年4月から施行された孤独・孤立対策推進法の関係でも、自治体における官民連携体制の整備に充てられる「孤独・孤立対策推進交付金」として、内閣府の2025年度補正予算で1億2,000万円、2026年度当初予算案で1億3,600万円が計上された。孤独・孤立の予防や早期対応に繋がる民間組織の活動を支援する予算も2025年度補正予算と2026年度当初予算案に経費が盛り込まれた。予算額はそれぞれ2億円、2,500万円。孤独・孤立を抱えた人をサポートする「つながりサポーター」の養成・普及として、2025年度補正予算で3億9,000万円が確保された。

2｜就職氷河期世代の支援など

1990年代後半から2000年代前半に社会人となった「就職氷河期」を対象にした支援策も盛り込まれた。この関係では、社会参加の支援など関係施策を列挙した「就職氷河期世代支援プログラム」が2019年6月に策定され、相談対応や社会参加支援などに取り組む自治体を支援する「地域就職氷河期世代支援加速化交付金」が2020年度から始まった。さらに、2025年4月には関係閣僚会議が発足し、2025年6月に示された「新たな就職氷河期世代等支援プログラムの基本的な枠組み」という政府文書では、相談体制の強化や就労支援、介護離職防止、多様な就労機会の確保、家計改善、住宅確保などの支援策が列挙された。

こうした動きを踏まえ、2025年度補正予算と2026年度当初予算案でも関係施策が盛り込まれた。例えば、厚生労働省の予算のうち、高齢者福祉の関係では、仕事と介護の両立支援に関わる施策が盛り込まれた。具体的には、介護保険財源を活用して地域のネットワークづくりなどに取り組む職種である「生活支援コーディネーター」の活動として、「就業している家族介護者への支援を念頭においた企業や都道府県労働局等との連携やネットワークづくり」が加えられた。さらに、介護保険財源を活用した地域支援事業で展開されている「家族介護支援事業」を拡充させ、相談窓口の設置などを促す。

高齢者福祉以外の予算としても、▽公共職業紹介所（ハローワーク）におけるキャリアコンサルティングなどの支援、▽生活困窮者自立支援事業で就労支援や企業との連携などに取り組む自治体を支援――といった施策が盛り込まれた。内閣府の施策としても、従来の地域就職氷河期世代支援加速化交付金として21億4,600万円が2025年度補正予算に継続的に計上されたほか、2026年度当初予算案でも就職氷河期世代支援の調査・広報を実施するための費用として、2,800万円が計上された。

このほか、2025年度から実施されている「賃上げ支援パッケージ」に基づく施策として、処遇の引き上げや働き方改革などに取り組む中小企業の助成金が拡充された。

3｜生活保護引き下げの最高裁判決に関わる対応

さらに、2025年度補正予算では生活保護引き下げに関わる最高裁判決への対応策として、1,475億円が盛り込まれた。

この関係では、政府が「デフレの影響で支給額が割高になっている」として、2013年度予算で生活保護の基準額を平均6.5%引き下げたものの、最高裁は2025年6月の判決で、検討手続きにおける瑕疵や、物価水準の恣意的な計算を問題視し、政府の判断の大半を「違法」とした。

これを受けた対応策として、2025年度補正予算では、原告と原告以外を区別せず、2.49%の水準で

 Copyright ©2026 NLI Research Institute All rights reserved

保護費を追加給付する一方、原告については2.49%の特別給付金を支給することになった。内訳は国負担の保護費1,055億円のほか、支給事務に必要な自治体に対する補助で401億円、問い合わせなどに対応する相談センターの設置などで17億円。

最後に今後の展望を占う各論として、(1) 少子化対策の財源確保、(2) 維新が重視する医療費適正化論議、(3) 給付付き税額控除の導入論議――を中心に議論の経過と論点を述べる。

10――少子化対策の財源確保や医療費適正化の行方は？

1｜少子化対策の財源確保

まず、少子化対策の財源確保である。既に触れた通り、岸田内閣が決定した「次元の異なる少子化対策」では、2028年度までに最大で約2兆円を医療・介護費のカットで賄うことが決まっている。さらに約2兆円のうち、約1兆円は公費（税金）で確保する一方、残りの約1.1兆円は社会保険料の抑制か、賃上げ分が充当されることになっており、社会保険料の部分は「子ども・子育て支援金」という形で医療保険料に上乗せされる。

政府の資料によると、2023年度から2026年度で計6,000億円が削減されたとされており、2028年度までに残り4,000～5,000億円程度の財源を捻出することが求められる。

2｜維新が重視する医療費適正化の行方は？

維新が重視する医療費適正化論議では、先に触れたOTC類似薬の保険給付見直しに加えて、高齢者の患者負担増や金融所得の加味などが想定される。

その際には、自民党と維新の政策協議の行方も要注目である。先に触れた通り、維新は社会保険料を引き下げるため、「医療費を年4兆円削減」という高い目標を掲げており、これまでの政策協議ではOTC類似薬の見直しや医療提供体制改革などについて、抜本的な見直しを唱えている。こうしたスタンスは2026年2月の総選挙で、自民党が圧勝した後も変わらないことが予想され、むしろ「巨大与党」に埋没しないため、主張を先鋭化させる可能性も考えられる。

しかし、様々な利害関係が絡む医療制度では、一気呵成な見直しが困難であり、結局は実現可能な制度改正に落ち着くと予想される。こうした展開は維新にとって、不満が残る結果になるが、与党入りのメリットを強調するため、「改革の糸口を作った」と説明する展開が考えられる。

実際、維新から見ると微温的な決着に終わったOTC類似薬の見直しについて、斎藤アレックス政調会長は「まだ小さな一歩かもしれないが、社会保険料を下げる風穴を空けるような改革になった」と述べたという[31]。筆者自身としては、こうした展開が今後、自民、維新双方の不満が極限に達するまで続くと見ている。

3｜給付付き税額控除の導入論議

3 点目の給付付き税額控除とは、税の控除と給付を一体的に実施する仕組みであり、中・低所得者

[31] 2025年12月19日『日本経済新聞電子版』を参照。

 Copyright ©2026 NLI Research Institute All rights reserved

に対して効率的に所得再分配を進められるツールとして、以前から関係者の間で注目されていた[32]。

この制度について、高市首相は就任当初から導入に前向きを示すとともに、税制と社会保障の一体改革に向けた「国民会議」を発足させ、2026 年夏頃に結論を出す考えを明らかにしている。2026 年 2 月には国民会議の第 1 回が開かれた。

しかし、導入には幾つかのハードルがありそうだ。まず、給付付き税額控除は所得の補足、税の還付、保険料の減免などが絡む仕組みであり、制度設計次第では社会保障と税の横断的かつ大掛かりな議論が求められる。第 2 に、自民党が 2025 年 2 月の総選挙公約で、食料品の消費税率を 2 年間限定で 0%にする方針を掲げたこととの整合性も論点になりそうだ。

第 3 に、国民会議自体がしりすぼみになる危険性である。実際、2026 年 2 月の初会合に向けて、高市政権が参加を要請した野党は中道改革連合、国民民主党、チームみらいの 3 党に限られ、参加したのもチームみらいにとどまるなど、議論の先行きに早くも暗雲が垂れ込んでいる。

11――おわりに

本稿では 2026 年度当初予算案のうち、社会保障予算の動向を中心に考察した。今回の予算編成では診療報酬本体の改定と重なったこともあり、医療・介護・福祉事業者に対するインフレ対応が大きな論点となった。結局、診療報酬本体としては 30 年ぶりの高い改定率となるなど、2025 年度補正予算での対応も含めて、相当なテコ入れが図られた。

その半面、少子化対策の財源確保だけでなく、維新の主張などを踏まえた社会保険料の抑制も論点になっており、インフレ対応で歳出を増やしつつ、給付を抑制するという難しい対応を強いられた。

さらに、中長期的には生産年齢人口が激減する 2040 年への対応を含めて、人材確保や医師偏在是正、身寄りのない高齢者への対応など問題は山積している[33]。

政権としては当面、2026 年度当初予算の早期成立に全力を尽くすことになるが、税制・社会保障の一体改革に関する「国民会議」を含めて、今後の制度改正に向けて、どんな新機軸が示されるのか、今後の動向を注視する必要がある。

---

[32] 最初に言及されたのは福田康夫政権期の 2007 年 11 月の政府税制調査会（首相の諮問機関）答申である。その後、2008 年 12 月の自民党税制調査会大綱でも言及があり、税制と社会保障の一体改革に向けた方向性や施策を盛り込んだ「持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた『中期プログラム』」が同月に閣議決定された際にも、社会保障目的の消費税増税の方針などとともに、「給付付き税額控除の検討を含む歳出面も合わせた総合的取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討する」という文言が盛り込まれ、この文言は 2009 年税制改正法の附則にも反映された。給付付き税額控除を巡る議論については、森信茂樹（2024）「ベーシックインカムと給付付き税額控除」財務省財務総合政策研究所『フィナンシャル・レビュー』通巻 157 号、加藤慶一（2009）「平成 21 年度税制改正案の概要」国立国会図書館『調査と情報』No. 631 のほか、2025 年 12 月 10 日『読売新聞』などを参照。

[33] 2040 年に向けた論点については、医療・介護や自治体行政に関する動向を網羅したコラムの第 1 回も参照。

本資料記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と完全性を保証するものではありません。
また、本資料は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。